EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Elemento	Descripción
Código	08-04-1.0
Nombre	Porcentaje de personas de alto riesgo (HT, DM2) con alteración renal inicial que cuentan con la confirmación de cronicidad.
Definición conceptual	Porcentaje de personas atendidas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas condiciones, que, tras presentar sospecha de ERC, reciben una prueba de seguimiento oportuno dentro del intervalo de tiempo establecido para confirmar o descartar cronicidad. Sospecha de Enfermedad Renal Crónica: presencia de al menos una determinación de la TFGe <60 ml/min/1.73 m², calculada mediante la ecuación CKD-EPI 2021 (sin ajuste racial), o una medición de albuminuria (RAC ≥30 mg/g) o proteinuria (IPC ≥150 mg/g), o alteraciones del sedimento urinario, histológicas o en pruebas de imagen. La TFGe se calcula con base en el valor de creatinina sérica, edad y sexo, utilizando la ecuación CKD-EPI 2021 (sin ajuste racial): TFG (ml/min/1.73m²) = 142 × min(Scr/κ, 1)^α1 × max(Scr/κ, 1)^−1.200 × 0.9938^edad × (1.012 si es mujer) Donde: Scr = creatinina sérica (mg/dL) κ (kappa) = 0.7 para mujeres, 0.9 para hombres α1(alfa) = −0.241 para mujeres, −0.302 para hombres edad = años cumplidos Prueba de seguimiento oportuno: Realización de una prueba de creatinina sérica, IAC o IPC, entre los 90 y 119 días, ya sea previa o posterior al resultado inicial alterado. Incluye: • Personas de 20 años y más con diagnóstico de HT, DM2 o ambas, que presentan sospecha de ERC entre los 118 días previos al inicio del periodo evaluado y los 119 días anteriores a su finalización (por ejemplo, entre el 4 de septiembre del año previo y el 3 de septiembre del año evaluado). Estas personas constituyen la población a la que corresponde realizar la prueba de seguimiento oportuno durante el periodo evaluado. • Pruebas de laboratorio clínico para seguimiento oportuno, con fecha de toma de muestra y resultado registrados, dentro del periodo evaluado. Excluye: • Personas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas, que presentan diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica (CIE-10 N18.0–N19) registrado en el año anterior.
Variables involucradas en la medición	• Personas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas, que presentan sospecha de ERC con prueba de seguimiento oportuno en el periodo • Personas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas, que presentan sospecha de ERC en el periodo

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Personas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas, que presentan sospecha de ERC con prueba de seguimiento oportuno en el periodo}}{\text{Personas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas, que presentan sospecha de ERC en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas no Transmisibles - ERC
Línea base	A definir con los resultados del análisis 2026 de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud.	
Meta	Quinquenal: En construcción.	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular, Cubo DCSS EPSS Generales, Reporte HT) • Consultas de primera vez por HT o DM2. • Consultas en el año anterior por ERC. • Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente que cuenten con fecha y resultado. Sistemas de laboratorio clínico (LABCORE, Sistema Integrado de Laboratorio Clínico). • Creatinina sérica, IAC ó IPC Fuente alternativa de resultados de laboratorio clínico	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual y monitoreo) • Informe de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (anual)	
Comentarios generales	La evaluación se centra exclusivamente en las pruebas bioquímicas fundamentales para valorar la función renal, sin incorporar estudios complementarios ni hallazgos del sedimento urinario, análisis histológicos o pruebas de imagen.	